

CAPÍTULO 14.31

Artritis Psoriásica y Artritis Asociada a EII

PERFIL EUNACOM 1.11.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Las espondiloartropatías seronegativas son un grupo de enfermedades inflamatorias que comparten características clínicas y genéticas (como la asociación con el HLA-B27). Dentro de este grupo, la **Artritis Psoriática** y la **Artritis asociada a Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII)** representan cuadros donde la inflamación articular se manifiesta en pacientes con patologías cutáneas o digestivas previas o concomitantes.

Artritis Psoriática (AP)

La artritis psoriática se define simplificada como la presencia de **Psoriasis** combinada con una **Espondiloartropatía**. Es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta tanto a las articulaciones como a los ligamentos y tendones (entesitis).

Clínica Articular

La presentación clínica puede ser muy variada, pero se caracteriza principalmente por: - **Oligoartritis periférica**: Es la forma más común. Suele ser **asimétrica** y afecta tanto a grandes como a pequeñas articulaciones. - **Compromiso Axial**: Puede afectar las articulaciones sacroilíacas (sacroilitis) y la columna vertebral, similar a la **Espondilitis Anquilosante**. - **Artritis Erosiva**: A diferencia de otras espondiloartropatías, la AP puede ser altamente erosiva y destructiva, lo que en ocasiones obliga a realizar el diagnóstico diferencial con la **Artritis Reumatoide**.

NOTA CLÍNICA

Aunque puede haber compromiso axial, en la artritis psoriática lo más frecuente es el **compromiso periférico**. Es fundamental buscar activamente la inflamación en las articulaciones interfalángicas distales, un sitio clásico de esta enfermedad.

Manifestaciones Cutáneas y Ungueales

El diagnóstico se apoya fuertemente en los hallazgos extra-articulares: - **Placas de Psoriasis**: Lesiones eritemato-descamativas clásicas, ubicadas frecuentemente en zonas extensoras (codos, rodillas) y en el cuero cabelludo. - **Afectación Ungueal**: Es un marcador de riesgo para desarrollar artritis. Se observan los famosos **pits ungueales** (pequeñas depresiones en la lámina de la uña) o el signo del "**piquete de pájaro**".

Hallazgos Característicos (Dactilitis)

La **dactilitis** o "dedos en salchicha" es la inflamación difusa de un dedo (mano o pie) debido a la inflamación simultánea de las articulaciones y las vainas tendinosas. - Si bien se ve en otras espondiloartropatías, es **mucho más frecuente y característica** en la artritis psoriática.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En el EUNACOM, si te presentan un paciente con artritis de articulaciones interfalángicas distales, dactilitis y lesiones descamativas en codos, la respuesta siempre es **Artritis Psoriática**.

Artritis Asociada a Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII)

Esta entidad se presenta en pacientes que padecen **Enfermedad de Crohn** o **Colitis Ulcerosa** y desarrollan una espondiloartropatía.

Características Principales

1. **Relación con la actividad intestinal**: En muchos casos (especialmente en la forma periférica tipo 1), los brotes de artritis coinciden con los brotes de la enfermedad intestinal. 2. **Tipos de afectación**: - **Periférica**: Suele ser pauciarticular y migratoria. -

Axial: Es independiente de la actividad del intestino y puede preceder por años al diagnóstico de la EII.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El uso de AINES en pacientes con EII debe hacerse con precaución, ya que en algunos pacientes pueden exacerbar o gatillar un brote de la enfermedad intestinal (Crohn o Colitis Ulcerosa).

Diagnóstico y Evaluación por Imágenes

El diagnóstico es fundamentalmente clínico, apoyado por el laboratorio (factor reumatoide negativo) y las imágenes.

TABLA 14.31.1: EXAMEN VS UTILIDAD EN ESPONDILOARTROPATÍAS

EXAMEN	UTILIDAD EN ESPONDILOARTROPATÍAS
Radiografía Simple	Primer examen a solicitar. Evalúa erosiones y daño estructural crónico.
Resonancia Magnética (RM)	El mejor examen para detectar inflamación precoz (edema óseo), especialmente en el esqueleto axial (sacroilitis).
Clínica	Fundamental para evaluar la artritis periférica y las manifestaciones cutáneas/ungueales.

Algoritmo de Tratamiento

El manejo busca controlar la inflamación articular y las manifestaciones de base (piel o intestino).

1. Manejo de la Artritis Psoriática

1. **AINES**: Primera línea para el manejo del dolor y la inflamación articular. 2. **Terapia Biológica (Anti-TNF)**: Se utiliza si no hay respuesta a los AINES o en casos de enfermedad erosiva/axial severa. 3. **Manejo Dermatológico**: Uso de corticoides tópicos, fototerapia o fármacos sistémicos según la extensión de la psoriasis cutánea.

2. Manejo de la Artritis por EII

1. **Tratar la EII de base**: Al controlar la inflamación intestinal, habitualmente mejora la artritis periférica. 2. **Sulfasalazina**: Es un fármaco de gran utilidad en este contexto, ya que tiene efecto tanto a nivel de la mucosa intestinal como en las articulaciones. 3. **AINES y Biológicos**: Se reservan para casos específicos, siempre vigilando la actividad intestinal.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

La **Sulfasalazina** es el fármaco "comodín" en la artritis asociada a EII, ya que sirve para ambas condiciones simultáneamente.

Resumen de Perlas Clínicas para el EUNACOM

- **Artritis Psoriática**: Sospechar ante oligoartritis asimétrica + lesiones en cuero cabelludo + pits ungueales.
- **Dactilitis**: Pensar inmediatamente en espondiloartropatías, principalmente la psoriática.
- **Uveítis y Eritema Nodoso**: Son complicaciones extra-articulares que pueden verse en ambos tipos de artritis.
- **Laboratorio**: Característicamente presentan **Factor Reumatoide (FR) negativo**, por eso se llaman "seronegativas".
- **Imagenología**: La RM es superior para ver sacroilitis incipiente que no se observa en la radiografía convencional.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Paciente con oligoartritis asimétrica, dactilitis y placas eritematodescamativas en codos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Artritis Psoriásica y Artritis Asociada a EII. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Artritis psoriásica: pelvispondiloartropatía + psoriasis; predominio periférico sobre axial
- Puede ser erosiva (diferencia con otras pelvispondiloartropatías; puede confundirse con AR)
- Dactilitis (dedos en salchicha) especialmente frecuente en artritis psoriásica
- Pits ungueales (psoriasis ungüal) + artritis = alta sospecha de artritis psoriásica
- Artritis asociada a EII: tratar la enfermedad intestinal mejora la artritis
- Sulfasalazina: útil tanto para EII como para la artritis asociada

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ARTRITIS PSORIÁSICA Y ARTRITIS ASOCIADA A EII)**PREGUNTA 1**

Paciente con oligoartritis asimétrica, dactilitis y placas eritematodescamativas en codos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Artritis reumatoide
- B)** Artritis psoriásica
- C)** Gota
- D)** Lupus eritematoso sistémico
- E)** Espondilitis anquilosante

PREGUNTA 2

¿Qué signo ungüal es característico de la psoriasis y apoya el diagnóstico de artritis psoriásica?

- A)** Líneas de Beau
- B)** Uñas en vidrio de reloj
- C)** Pits ungueales (piquete de pájaro)
- D)** Onicolisis distal
- E)** Leuconiquia

PREGUNTA 3

Paciente con enfermedad de Crohn y oligoartritis asimétrica. ¿Cuál es el manejo más adecuado?

- A)** Metotrexato exclusivamente
- B)** Tratar la enfermedad inflamatoria intestinal (con lo cual suele mejorar la artritis)
- C)** Corticoides intraarticulares solamente
- D)** Ciclofosfamida
- E)** Hidroxicloroquina

RESUMEN: ARTRITIS PSORIÁSICA Y ARTRITIS ASOCIADA A EII

La artritis psoriásica es una pelvispondiloartropatía asociada a psoriasis. Se presenta con oligoartritis periférica asimétrica (más frecuente que el compromiso axial, aunque puede afectar sacroilíacas y columna), puede ser erosiva (pudiendo confundirse con artritis reumatoide), y se asocia a signos de psoriasis (placas eritematodescamativas en zonas extensoras y cuero cabelludo, pits ungueales). La dactilitis (dedos en salchicha) es especialmente frecuente. El diagnóstico es clínico más imágenes (radiografía primero, resonancia el mejor). Tratamiento con AINEs y biológicos de segunda línea, más manejo dermatológico de la psoriasis. La artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal es una pelvispondiloartropatía asociada a enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. El tratamiento es tratar la EII (con lo cual suele mejorar la artritis), usando AINEs para la artritis, sulfasalazina como opción intermedia, y biológicos de segunda línea.